Pulsos arteriales y enfermedad arterial y venosa periférica

SEMIOLOGIA · Clase 11 · dónde se palpa el pulso, qué dice, y qué pasa cuando la arteria o la vena fallan

1 · DÓNDE SE PALPA EL PULSO

Pulso arterial
onda de la sístole del ventrículo izquierdo que se palpa en la arteria

al tacto revela la pared:

para palparlo exige un

Sitio adecuado
arteria superficial, sobre un plano óseo y de calibre al menos mediano

en el pie lo cumplen los

lo cumple mejor la

Arteria radial
sitio de elección: tres pulpejos sobre ella, apoyada en el radio

F4 **Pulsos del pie**
pedio en el dorso, entre el 1.º y el 2.º metatarsiano; tibial posterior detrás del maléolo medial; la tibial anterior no se palpa

su permeabilidad se prueba con la

si cae el gasto, se busca en el

F5 **Maniobra de Allen**
comprimir radial y cubital, abrir la mano pálida y soltar una: la palma se recolorea en menos de 10 s si la arteria es permeable

Paro cardiorrespiratorio
se palpa carótida o femoral: la radial desaparece antes porque cae el gasto

sus hallazgos entran en la

si tampoco se palpa se inicia la

Sin pulso central
iniciar RCP

2 · QUÉ DICEN LA PARED, LA FRECUENCIA Y EL RITMO

F1 **Pared del joven**
lisa, blanda y depresible

con el envejecimiento se vuelve

F1 **Pared con arteriosclerosis**
rígida y tortuosa: como cordel o tráquea de pollo

la pared entra en la

Frecuencia
contar un minuto completo; adulto 60 a 100/min, recién nacido ≈ 145

si supera 100/min

se cuenta la

Taquisfigmia (más de 100/min)
ejercicio, emoción, fiebre (+12 a 15/min por °C) o shock

la frecuencia entra en la

si baja de 60/min

Bradisfigmia (menos de 60/min)
sueño, atleta o bloqueo AV (30 a 40/min)

la frecuencia entra en la

si un latido llega adelantado, hay una

F2 **Extrasístole**
latido adelantado seguido de pausa; no siempre es cardíaca: café, alcohol, tabaco, estrés, insuficiencia cardíaca, valvulopatías

al comparar con el corazón halla el

si es ventricular puede dar

Déficit de pulso
los latidos auscultados superan a los radiales: contracciones ineficaces

orienta a arritmia en la

el ritmo entra en la

Interpretación del pulso
pared, frecuencia y ritmo orientan la perfusión y el mecanismo cardíaco

si cae, se compara con el otro lado:

3 · AMPLITUD Y FORMA DE LA ONDA

F3 **Dónde se encuentra**
derrame pericárdico (no pleural), taponamiento, pericarditis constrictiva, enfisema, asma y EPOC

comprimen el corazón y causan un

se valora su

Amplitud
cuánto se eleva la onda bajo el dedo

Corazón comprimido
al inspirar se llena menos el ventrículo izquierdo y eyecta menos

si es amplia y rápida

si es pequeña

produce el

si cae al inspirar

Pulso celer
amplio, sube y baja rápido: insuficiencia aórtica

Pulso parvus
pequeño: estenosis aórtica

válvula aórtica estrecha en el

F3 **Pulso paradójico**
la amplitud cae al inspirar y la sistólica baja más de 10 mmHg (2018: 10 a 12)

válvula aórtica en el

pericardio o pulmón en el

Mecanismo probable
la onda orienta a válvula, pericardio o pulmón

4 · LA ARTERIA QUE SE CIERRA

Ateroma
lípidos, plaquetas, fibrina y calcio estrechan la luz; lo aceleran HTA, diabetes, tabaco, obesidad y sedentarismo

a diferencia del espasmo episódico del

estrecha la luz y causa la

Falta sangre al caminar
la luz estrecha basta en reposo pero no cubre lo que pide el músculo

Embolia arterial
de origen cardíaco (fibrilación auricular, estenosis mitral, infarto reciente): más del 70 % de la isquemia aguda

F6 **Fenómeno de Raynaud**
espasmo episódico de las arterias de los dedos por frío o estrés, en mujeres jóvenes: palidez, cianosis y rubor

al caminar da la

ocluye de golpe y da la

pasa por tres fases y es

F7 **Claudicación intermitente**
calambre de pantorrilla al caminar que obliga a parar y cede con reposo: el dolor es el síntoma inicial

Isquemia aguda
dolor súbito (70 %), piel fría y pálida y pulso distal ausente

F6 **Reversible**
no es palidez fija ni gangrena: el dedo vuelve a la normalidad

se confirma palpando la

si caen las colaterales, hay una

para ubicar el nivel se hace la

Palpación comparativa
femoral, poplíteo y tibiales frente al miembro sano: donde cae el pulso está la obstrucción

Falla la colateral
piel y nervios sin riego aun en reposo

se confirma con la

Ecografía Doppler
confirma la obstrucción arterial y la localiza

deja la piel sin riego:

si el pulso falta, es la

si el flujo arterial está cortado, es la

F8 **Isquemia crónica avanzada**
dolor en reposo, piel fría y pálida, sin vello y úlcera seca periungueal

con trauma mínimo o frío aparece la

Gangrena
precipitada por trauma mínimo o frío ambiental

puede terminar en la

Amputación distal
desenlace de la isquemia crónica avanzada

5 · LA VENA QUE FALLA

Presión venosa alta
bipedestación, obesidad, embarazo, ascitis y válvulas insuficientes

con estasis activa la

dilata la vena y origina las

Várices
dilataciones venosas permanentes; más del 40 % de las mujeres mayores de 40 años

Tríada de Virchow
lesión endotelial, estasis venosa e hipercoagulabilidad

con los años la piel muestra

forma el trombo de la

Piel venosa
hiperpigmentación, eczema y edema

Trombosis venosa profunda
edema unilateral de pantorrilla (≈ 90 %) y dolor; Homans y Olow orientan

hincha un solo lado: es la

si avanza termina en la

si el trombo migra da la

se confirma con la

F8 **Úlcera varicosa**
en el tobillo (maleolar interna): la úlcera de pierna más frecuente

F9 **Ecografía Doppler venosa**
confirma el trombo: la clínica solo orienta

Embolia pulmonar
si el trombo migra: disnea súbita y dolor pleurítico

en el tobillo con pulso presente es la

obliga a la

confirmada exige

Anticoagulación
inmediata tras confirmar la trombosis

6 · ARTERIA O VENA: CÓMO SE DISTINGUE

Es la arteria
dolor al caminar, pie frío, sin vello y sin pulso

Es la vena
pierna hinchada, oscura y con venas, con pulso

concepto · técnica · desenlace · signo · causa · mecanismo · síntoma · complicación · diagnóstico · síndrome · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor, Semiología (05d, 08e, 08i) — teoría del docente; = literatura